ONEMA-POP-048 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-048 — Reconhecimento e Escalonamento da
Síndrome de Abstinência Alcoólica

1. Identificação institucional

técnica

2. Objetivo e abrangência

Padronizar a atuação de enfermagem em: Reconhecimento e Escalonamento da Síndrome de Abstinência Alcoólica. Aplicável a visitas e/ou triagem digital conforme pertinência, sem substituir serviço de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado, treinado e autorizado; Suspeita de abstinência alcoólica após redução ou interrupção do uso; risco de convulsões e delirium tremens. Não realizar intervenções além da competência, prescrição ou recursos disponíveis.

4. Materiais e equipamentos; fornecimento

Enfermeiro: sinais vitais na visita, roteiro de consumo, contato emergencial; paciente: histórico de uso e medicações. Equipamentos de avaliação clínica de uso profissional são providos pelo enfermeiro; consumíveis do paciente conforme contratação.

5. Avaliação clínica e preparação

Última ingestão, padrão de consumo, abstinência prévia grave, convulsões, tremor, sudorese, agitação, alucinações e comorbidades. Confirmar identificação, consentimento, privacidade e localização para eventual emergência.

6. Execução técnica individualizada

1. Determinar última ingestão e histórico de convulsão ou delirium em abstinências anteriores.

2. Avaliar orientação, agitação, tremores, sudorese, náuseas, alucinações e sinais vitais quando presencial.

3. Investigar uso concomitante de sedativos, opioides e condições clínicas agudas.

4. Se convulsão, confusão, alucinações intensas ou instabilidade, acionar SAMU 192.

5. Não recomendar interrupção abrupta sem avaliação quando houver dependência e risco de abstinência grave.

6. Não prescrever nem administrar benzodiazepínicos sem prescrição, competência e estrutura apropriadas.

7. Se quadro leve e estável, articular avaliação médica tempestiva e rede de apoio, com reavaliação definida.

8. Documentar risco, encaminhamento, recusa e orientações à família.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Convulsão, delirium, febre, instabilidade autonômica ou desidratação grave: emergência.

8. Cuidados posteriores e orientações

Explicar risco de piora nas primeiras horas/dias e necessidade de avaliação profissional.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Registrar identificação, data/hora, modalidade, consentimento, queixa, avaliação, achados positivos/negativos, etapas realizadas, intervenções não realizadas e justificativa, comunicação com RT/rede, encaminhamento, orientações, plano de retorno e assinatura do enfermeiro.

10. Referências específicas e rastreáveis

 OMS — mhGAP Intervention Guide v2.0, avaliação e manejo de psicose/agitação — https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/250239/9789241549790-eng.pdf

 NICE CG100 — Alcohol-use disorders: diagnosis and management of physical complications — https://www.nice.org.uk/guidance/cg100

Referências consultadas como suporte temático; a correspondência exaustiva entre cada passo e a evidência, bem como regras locais e manuais dos fabricantes, requer análise pelo RT.